

HEALTHMAIS · ATENDIMENTO DOMICILIAR

Painel de Indicadores

Competência 08/2026 · modelo recategorizado em dez cards

Gerado em 28/08/2026

Recorte: todos os períodos · todas as operadoras · AD e ID

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os dez cards no período

Cada card traz seu valor principal e a situação frente à meta. O card 03 é espelho da saída por óbito registrada no card 01 e não soma ao painel; o card 07 é campo de valor, não contador.

Card	Indicador	Principal	Referência	Meta	Situação
01	Movimentação da Carteira	8	Movimentações	Saídas não eletivas ≤ 30% das saídas do mês	Fora da meta
02	Intercorrências e Resolutividade	8	Intercorrências	Resolutividade no domicílio ≥ 70%	Fora da meta
03	Óbitos	3	Óbitos	—	Sem meta
04	Adequação e Execução do PAD	7	Alterações	Aderência ao PAD ≥ 90%	Atingida
05	Eventos Adversos	8	Eventos	Eventos com dano grave ou óbito = 0	Fora da meta
06	Lesões de Pele	7	Lesões ativas	Lesões adquiridas sob assistência ≤ 2 no mês	Fora da meta
07	Custo e Evitabilidade das Lesões	R\$ 17.565,90	Custo do período	Custo evitável ≤ 30% do custo do período	Fora da meta
08	Infecção e Antimicrobianos	7	Infecções	Infecção relacionada à assistência ≤ 40%	Fora da meta
09	Ouvidoria	8	Manifestações	Resposta dentro do SLA ≥ 90%	Atingida
10	Vulnerabilidade e Proteção Social	6	Casos	Nenhum caso em triagem com prazo vencido	Atingida

CARD 01

Movimentação da Carteira

Cada linha é um episódio de cuidado, não um evento solto. A admissão abre o episódio; o desfecho (1.2 a 1.7) o fecha. Ninguém some da base — o episódio encerra.

FORA DA META · Saídas não eletivas ≤ 30% das saídas do mês

MOVIMENTAÇÕES	ADMISSÕES (1.1)	SAÍDAS (1.2 – 1.7)	EPISÓDIOS ABERTOS
8	2	6	4
no mês	entradas	desfechos registrados	carteira ativa

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Mar	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
01 — Movimentação da Carteira	1	1	2	4	8	16
1.1 Admissão	1	1	2	4	2	10
1.2 Alta por objetivo terapêutico	—	—	—	—	1	1
1.3 Alta por transição de nível	—	—	—	—	1	1
1.4 Saída por óbito	—	—	—	—	1	1
1.5 Saída por internação prolongada	—	—	—	—	1	1
1.6 Desligamento administrativo	—	—	—	—	1	1
1.7 Transferência para outra prestadora	—	—	—	—	1	1

CARD 02

Intercorrências e Resolutividade

A taxa de internação hospitalar sai daqui, do desfecho 2.4 — o antigo card 03 deixou de existir. 2.3 e 2.4 são desfechos diferentes e nunca se somam.

FORA DA META · Resolutividade no domicílio ≥ 70%

INTERCORRÊNCIAS	RESOLVIDAS NO DOMICÍLIO	TAXA DE INTERNAÇÃO	REMOÇÕES COM RETORNO
8	37,5%	25%	2
no período	2.1 + 2.2 — resolutividade	derivada de 2.4	2.3 — retorno em 24h

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Ago	Total
02 — Intercorrências e Resolutividade	8	8
2.1 Resolvida pela equipe no domicílio	2	2
2.2 Resolvida com suporte médico	1	1
2.3 Remoção APH com retorno em até 24h	2	2
2.4 Remoção com internação hospitalar	2	2
2.5 Óbito durante a intercorrência	1	1

PENDÊNCIAS DO CARD

INT-0915	Iracema D. Bastos	Campo obrigatório em falta: Data e hora; Data de retorno ao domicílio
INT-0924	Adalberto S. Nogueira	Internação classificada como evitável. Entra no numerador do indicador de evitabilidade e dispara revisão do plano de cuidado.
INT-0924	Adalberto S. Nogueira	Campo obrigatório em falta: Data e hora; Data de retorno ao domicílio

CARD 03

Óbitos

Detalhamento clínico das saídas por óbito registradas no card 01 (1.4). Serve à revisão de caso, não à contagem — por isso não soma ao painel.

Espelho de 1.4 — não soma ao painel

ÓBITOS	COM PLANO PALIATIVO	NÃO ESPERADOS	EM ATÉ 48H DA ADMISSÃO
3	1	1	1
espelho de 1.4	3.1 — formalizado	3.3 — revisão obrigatória	alerta para a diretoria

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Ago	Total
03 — Óbitos	3	3
3.1 Esperado, com plano paliativo formalizado	1	1
3.2 Esperado, sem plano formalizado	1	1
3.3 Não esperado	1	1

PENDÊNCIAS DO CARD

OBT-0072	Firmino J. Aguiar	Alerta de revisão de caso enviado à diretoria médica. Disparado por óbito em até 48h da admissão ou classificado como não esperado (3.3).
OBT-0072	Firmino J. Aguiar	Campo obrigatório em falta: Diretivas antecipadas registradas
OBT-0073	Dulcinéia B. Rezende	Campo obrigatório em falta: Diretivas antecipadas registradas

CARD 04

Adequação e Execução do PAD

Duas coisas no mesmo card: as alterações do plano (4.1 a 4.4) e a execução do mês — previstos contra realizados.

META ATINGIDA · Aderência ao PAD ≥ 90%

ALTERAÇÕES	ATENDIMENTOS PREVISTOS	ATENDIMENTOS REALIZADOS	ADERÊNCIA
7 no mês	1.284 conforme PAD vigente	1.173 111 não realizados	91,4% realizados / previstos

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Ago	Total
04 — Adequação e Execução do PAD	7	7
4.1 Ampliação do plano	2	2
4.2 Redução do plano	2	2
4.3 Mudança de modalidade AD ↔ ID	2	2
4.4 Suspensão ou encerramento do plano	1	1

CARD 05

Eventos Adversos

Lesão por pressão saiu deste card e passou para o 06, como episódio próprio. O que fica aqui são eventos pontuais, com grau de dano e prazo de análise causal de 7 dias.

FORA DA META · Eventos com dano grave ou óbito = 0

EVENTOS	COM DANO GRAVE OU ÓBITO	NEAR MISS (5.9)	ANÁLISE CAUSAL VENCIDA
8	2	1	1
no mês	revisão obrigatória	não atingiu o paciente	prazo de 7 dias

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Ago	Total
05 — Eventos Adversos	8	8
5.1 Queda sem dano	1	1
5.2 Queda com dano	1	1
5.3 Broncoaspiração	1	1
5.4 Decanulação acidental	1	1
5.5 Saída acidental de GTT ou SNE	1	1
5.6 Saída acidental de SVD, cistostomia ou PICC	—	0
5.7 Erro ou omissão de medicação	1	1
5.8 Falha ou falta de equipamento	1	1
5.9 Near miss — não atingiu o paciente	1	1

PENDÊNCIAS DO CARD

EA-0233	Firmino J. Aguiar	Análise causal vencida. O prazo é de 7 dias a partir da notificação — venceu em 24/08/2026.
EA-0233	Firmino J. Aguiar	Campo obrigatório em falta: Data de conclusão da análise causal
EA-0236	Marta L. Andrade	Campo obrigatório em falta: Data de conclusão da análise causal

CARD 06

Lesões de Pele

Cada lesão é um episódio com abertura, série de avaliações e fechamento — não uma contagem de ocorrências. A origem é derivada da primeira avaliação com foto.

FORA DA META · Lesões adquiridas sob assistência ≤ 2 no mês

LESÕES ATIVAS	PRESENTE NA ADMISSÃO	ADQUIRIDA SOB ASSISTÊNCIA	CICATRIZADAS NO PERÍODO
7	2	5	2
em 118 episódios abertos	não conta como adquirida	indicador de resultado	fechadas em 08/2026

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
06 — Lesões de Pele	1	2	1	5	9
6.1 LPP estágio 1	—	1	—	—	1
6.2 LPP estágio 2	1	—	—	1	2
6.3 LPP estágio 3 ou 4	—	—	1	—	1
6.4 LPP não classificável ou tissular profunda	—	—	—	1	1
6.5 Lesão por dispositivo médico	—	—	—	1	1
6.6 Dermatite associada à incontinência	—	—	—	1	1
6.7 Úlcera venosa, arterial ou pé diabético	—	1	—	—	1
6.8 Ferida operatória ou skin tear	—	—	—	1	1

PENDÊNCIAS DO CARD

LES-0442	Neusa A. Prado	Sem foto em 48h da implantação. O sistema gravou esta lesão como adquirida sob assistência. Anexar a foto datada reclassifica o episódio.
LES-0442	Neusa A. Prado	Campo obrigatório em falta: Foto datada
LES-0451	Odete S. Maranhão	Campo obrigatório em falta: Escala de Braden
LES-0459	Zulmira N. Peixoto	Campo obrigatório em falta: Data de abertura; Data prevista de reavaliação

CARD 07

Custo e Evitabilidade das Lesões

Campo de valor, não contador. Todo lançamento é vinculado a um episódio de lesão do card 06 — nunca solto no paciente.

FORA DA META · Custo evitável $\leq$ 30% do custo do período

CUSTO DO PERÍODO	CUSTO EVITÁVEL	CUSTO POR EPISÓDIO ENCERRADO	RISCO DE GLOSA
R\$ 17.565,90 todos os episódios	70,5% lesões adquiridas sob assistência	R\$ 1.565,55 2 episódios fechados	29,2% internação atribuída à lesão adquirida

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
07 — Custo e Evitabilidade das Lesões	R\$ 2.912,20	R\$ 4.453,20	R\$ 2.846,40	R\$ 7.354,10	R\$ 17.565,90
7.1 Coberturas e insumos de curativo	R\$ 1.640,20	R\$ 2.358,90	R\$ 1.284,40	R\$ 1.496,10	R\$ 6.779,60
7.2 Horas de enfermagem em curativo	R\$ 1.272,00	R\$ 1.608,00	R\$ 942,00	R\$ 318,00	R\$ 4.140,00
7.3 Visitas extras de enfermeiro ou estomaterapeuta	—	—	R\$ 620,00	—	R\$ 620,00
7.4 Equipamentos de prevenção e terapia	—	—	—	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
7.5 Rateio de antimicrobianos e exames de ferida	—	R\$ 486,30	—	—	R\$ 486,30
7.6 Rateio de internação atribuída à lesão	—	—	—	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00

PENDÊNCIAS DO CARD

CST-0459	Zulmira N. Peixoto	Risco de glosa. Há rateio de internação atribuída a uma lesão adquirida sob assistência. A operadora pode recusar o valor.
-----------------	--------------------	--

CARD 08

Infecção e Antimicrobianos

O corte antigo por tempo de antibiótico deixou de existir. A classificação agora é por topografia, e o alerta dispara com 10 dias ou mais de uso sem reavaliação.

FORA DA META · Infecção relacionada à assistência ≤ 40%

INFECÇÕES	COMUNITÁRIA OU NA ADMISSÃO	RELACIONADA À ASSISTÊNCIA	ANTIMICROBIANO ≥ 10 DIAS
7	3	4	2
no mês	não atribuída à assistência	indicador de resultado	sem reavaliação registrada

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Jul	Ago	Total
08 — Infecção e Antimicrobianos	1	6	7
8.1 ITU associada a cateter vesical	—	1	1
8.2 ITU sem cateter	—	1	1
8.3 Respiratória com traqueostomia ou VM	—	1	1
8.4 Pneumonia aspirativa	—	1	1
8.5 Sítio de inserção de GTT, PICC ou TQT	—	1	1
8.6 Ferida ou lesão por pressão infectada	—	1	1
8.7 Pele e partes moles	1	—	1
8.8 Outras topografias	—	—	0

PENDÊNCIAS DO CARD

INF-0341	Iracema D. Bastos	Antimicrobiano há 13 dias sem reavaliação. Alerta automático para a equipe médica a partir de 10 dias de uso.
INF-0350	Sebastião P. Rocha	Antimicrobiano há 10 dias sem reavaliação. Alerta automático para a equipe médica a partir de 10 dias de uso.
INF-0350	Sebastião P. Rocha	Campo obrigatório em falta: Cultura coletada antes do antibiótico
INF-0359	Neusa A. Prado	Campo obrigatório em falta: Cultura coletada antes do antibiótico

CARD 09

Ouvidoria

A categoria “Reclamações e Solicitações” foi extinta. Manifestação com mais de um teor é classificada pelo de maior criticidade; os demais entram como motivo adicional.

META ATINGIDA · Resposta dentro do SLA ≥ 90%

MANIFESTAÇÕES	RECLAMAÇÕES (9.1)	EM ABERTO	RESPOSTA NO PRAZO
8	3	2	100%
no mês	maior criticidade	1 fora do SLA	SLA de 5 dias úteis

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Ago	Total
09 — Ouvidoria	8	8
9.1 Reclamação	3	3
9.2 Solicitação	2	2
9.3 Sugestão	1	1
9.4 Elogio	1	1
9.5 Dúvida ou pedido de informação	1	1

PENDÊNCIAS DO CARD

OUV-0612	Marta L. Andrade	Campo obrigatório em falta: Procedência; Data de resposta
OUV-0615	Genésio T. Vilar	SLA de resposta vencido. O prazo de 5 dias úteis expirou em 27/08/2026.
OUV-0615	Genésio T. Vilar	Campo obrigatório em falta: Procedência; Data de resposta

CARD 10

Vulnerabilidade e Proteção Social

“Em triagem” substitui a antiga “não categorizada” e é status temporário com prazo de 7 dias. Nenhum caso encerra a competência sem categoria.

META ATINGIDA · Nenhum caso em triagem com prazo vencido

CASOS	EM TRIAGEM	NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	SEM AVALIAÇÃO EM 72H
6	1	1	1
no mês	prazo de 7 dias	acionada no período	serviço social

EVOLUÇÃO MENSAL

Indicador	Ago	Total
10 — Vulnerabilidade e Proteção Social	6	6
10.1 Negligência ou abandono do cuidado	1	1
10.2 Violência física	—	0
10.3 Violência psicológica	—	0
10.4 Violência sexual	—	0
10.5 Violência financeira ou patrimonial	—	0
10.6 Ausência ou insuficiência de cuidador	1	1
10.7 Moradia inadequada ou ambiente inseguro	1	1
10.8 Conflito familiar que interfere no plano	1	1
10.9 Recusa ou sabotagem do cuidado	1	1
—Em triagem	1	1

PENDÊNCIAS DO CARD

VUL-0128	Odete S. Maranhão	Caso em triagem. Status temporário com prazo de 7 dias, até 01/09/2026. A competência não fecha com caso sem categoria.
VUL-0128	Odete S. Maranhão	Campo obrigatório em falta: Avaliação do serviço social em até 72h; Conduta adotada

VIRADA DE MODELO

O que vem do sistema atual

Nenhuma função existente se perde. Para cada página do sistema em uso, o que é mantido, o que muda de forma e o que passa a existir.

Eventos

Mantido	Filtro por intervalo da data de ocorrência, busca, ordenação e anexo de arquivo até 5 MB por registro.
Muda	Deixa de existir “indicador + subindicador genérico”: cada linha abre no formulário tipado da sua categoria.
Novo	Coluna de origem do registro — sistema ou legado importado — para separar o histórico migrado.

Pacientes

Mantido	Cadastro, anexo de documento e histórico por paciente.
Muda	O paciente deixa de carregar a lista de eventos embutida; passa a ter episódios de cuidado, e o histórico é montado por consulta.
Novo	Um episódio aberto por paciente é garantido pelo banco, não por validação de tela.

Pacientes inativos

Mantido	Página própria, com motivo e data da inativação.
Muda	“Inativo” vira consequência do episódio fechado (saída 1.2 a 1.7), não uma flag solta no paciente.
Novo	Reabertura de episódio é um registro novo, com data e responsável, em vez de reverter a flag.

Relatórios

Mantido	Pivô mensal, evolução por período, exportação em PDF e recorte por operadora.
Muda	Os números saem de views do banco, não de contagem no navegador — o relatório passa a bater com o painel por construção.
Novo	Recorte por origem do registro e comparação entre competências fechadas.

Certificados

Mantido	Layout de frente e verso, assinatura e geração para impressão.
Muda	Sai do bundle do painel e vira geração sob demanda, com o mesmo modelo.
Novo	Registro de emissão fica na auditoria: quem emitiu, quando e para quem.

Registros do formulário público

Mantido	Formulário público, fila de pendentes e vínculo manual ao paciente.
Muda	As categorias liberadas deixam de ser prefixo de texto (“08 -”, “09 -”, “10 -”) e passam a ser marcadas no catálogo.
Novo	Enquanto pendente, o registro não entra em nenhum indicador — hoje isso depende de o admin lembrar de vincular.

Auditoria

Mantido	Trilha completa por registro, com autor e data.
Muda	Sai do event store manual em Mongo e passa a trigger de auditoria no Postgres — mesma informação, sem depender de a aplicação lembrar de gravar.
Novo	Diferença campo a campo entre versões, e não só o payload inteiro.

Usuários e acesso

Mantido	Login, perfis e controle de acesso por página.
Muda	Autorização passa a ser verificada também na API, por recurso — hoje a checagem é predominantemente de tela.
Novo	Perfil somente-leitura para auditoria da operadora.

Notificações

Mantido	Sino com contador, marcação de lido e link para o registro.
Muda	Deixa de ser só “novo evento”: as regras do documento viram alertas — óbito em 48h, antimicrobiano com 10 dias, SLA da ouvidoria, triagem de 7 dias.
Novo	Alerta com destinatário definido por regra, como a revisão de caso que vai à diretoria médica.

Fechar competência

Novo	Não existe hoje. O fechamento recusa competência com caso em triagem, análise causal vencida ou campo obrigatório faltando.
Muda	Depois de fechada, a competência vira leitura: correção exige registro de retificação com autor e motivo.

Aprovação da competência 08/2026

Coordenação de enfermagem

Diretoria médica